

Razonamiento clínico — Espalda

bodyPart: back · entry: bk_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 12

Entrada alternativa por test del informe

- **slr-lasegue** → bk_slr
- **kemp** → bk_kemp
- **schober** → bk_schober

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Lumbar — árbol maestro Physioguide

id: bk_master_entry

Resumen: Flujo: cauda/RF → ¿ciática vs mecánico? → SLR/Kemp con cautela → Schober si inflamatorio. Nunca SLR = hernia; nunca Kemp = faceta.

Hipótesis:

- **Enrutar por urgencia y patrón radicular vs local** (alta) — Cauda → hospital. Pierna bajo rodilla → ciática. Solo lumbar → mecánico.
- Continúa en: **bk_cauda_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Red flags de cauda equina u otra urgencia?

id: bk_cauda_gate

testId: route-back-cauda

Descripción: Silla de montar, retención/incontinencia, anestesia perineal, paresia grave → HOSPITAL. También fiebre/cáncer/fractura según contexto.

Procedimiento: Enrutado de urgencia.

- **Positivo / Sí:** Silla de montar / esfínteres / paresia grave → **bk_cauda_cluster**
- **Negativo / No:** Sin cauda → **bk_radicular_gate**

3. [CONCLUSIÓN] Sospecha de cauda equina / urgencia — HOSPITAL

id: bk_cauda_cluster

Resumen: No tests de consulta. Derivación inmediata.

Hipótesis:

- **Cauda equina / urgencia neurológica** (alta) — Síntomas de alarma perineales/esfinterianos/paresia.
- Nodo terminal (fin de rama).

4. [TEST / GATE] ¿Irradiación tipo ciática?

id: bk_radicular_gate

testId: route-back-sciatica

Descripción: Pierna (sobre todo bajo rodilla) → SLR familiar. Solo lumbar → mecánico; Kemp con cautela.

Procedimiento: Enrutado clínico.

- **Positivo / Sí:** Dolor irradiado (típ. bajo la rodilla) → **bk_sciatica_cluster**

→ **Negativo / No:** Dolor lumbar local ± glúteo → **bk_mechanical_cluster**

5. [CONCLUSIÓN] Compatible con irritación nerviosa / ciática

id: bk_sciatica_cluster

Resumen: SLR familiar apoya; no confirma hernia. Crossed SLR más específico si positivo. Cribar cadera/pie.

Hipótesis:

- **Radiculopatía lumbar / ciática** (alta) — Irradiación + SLR familiar.
- **Referido de cadera / otra causa** (media) — Si patrón atípico.

→ Continúa en: **bk_slr**

6. [CONCLUSIÓN] Compatible con lumbalgia mecánica inespecífica

id: bk_mechanical_cluster

Resumen: Sin cluster radicular ni RF. No inventar faceta/disco/SI definitivos. Kemp = dolor mecánico local, no faceta confirmada.

Hipótesis:

- **Lumbalgia mecánica inespecífica** (alta) — Patrón mecánico local.
- **Cribado inflamatorio si rigidez matutina prolongada** (baja) — Schober + historia ASAS → derivación.

→ Continúa en: **bk_kemp**

7. [TEST / GATE] SLR / Lasègue

id: bk_slr

testId: slr-lasegue

Descripción: Elevación pasiva de pierna recta. Dolor ciático / radicular antes de 60°.

Procedimiento: Elevación pasiva de pierna recta. Dolor ciático / radicular antes de 60°.

Evidencia: van der Windt Cochrane: sensible, poco específico. Ciática familiar (pierna), no tirón isquiotibial. Cruzado más específico. No confirma hernia.

→ **Positivo / Sí:** Dolor ciático familiar en la pierna → **bk_sciatica_cluster**

→ **Negativo / No:** Solo tirón isquiotibial / no familiar → **bk_kemp**

8. [TEST / GATE] Kemp / cuadrante lumbar

id: bk_kemp

testId: kemp

Descripción: Extensión + inclinación lateral y rotación hacia el lado doloroso.

Procedimiento: Extensión + inclinación lateral y rotación hacia el lado doloroso.

Evidencia: Evidencia LIMITADA como test facetario. Dolor mecánico local en extensión; no confirma artrosis ni indica infiltración (JOSPT LBP CPG).

→ **Positivo / Sí:** Dolor lumbar local en extensión/cuadrante → **bk_mechanical_local**

→ **Negativo / No:** Kemp no familiar → **bk_schober**

9. [CONCLUSIÓN] Dolor mecánico local (no «faceta confirmada»)

id: bk_mechanical_local

Resumen: Kemp/cuadrante doloroso local. Evidencia limitada para síndrome facetario. No indicar infiltración por un test.

Hipótesis:

- **Dolor lumbar mecánico local** (alta) — Extensión/cuadrante familiar.

→ Continúa en: **bk_schober**

10. [TEST / GATE] Test de Schober

id: bk_schober

testId: schober

Descripción: Marca L5 y 10 cm arriba; flexión lumbar. Incremento <5 cm sugiere limitación.

Procedimiento: Marca L5 y 10 cm arriba; flexión lumbar. Incremento <5 cm sugiere limitación.

Evidencia: ASAS / Schober modificado: cribado de rigidez inflamatoria, no hernia ni lumbalgia inespecífica.

→ **Positivo / Sí:** Limitación de flexión + contexto inflamatorio → **bk_inflammatory**

→ **Negativo / No:** Schober no sugestivo / sin contexto SpA → **bk_nonspecific**

11. [CONCLUSIÓN] Cribado inflamatorio — valorar derivación

id: bk_inflammatory

Resumen: Schober reducido + joven + rigidez matutina + mejora con actividad → SpA cribado. No diagnosticar AS ni hernia por Schober solo.

Hipótesis:

- **Posible dolor inflamatorio / SpA (cribado)** (media) — Patrón inflamatorio + Schober.

- **Lumbalgia mecánica con espasmo** (media) — Sin contexto inflamatorio claro.

→ Nodo terminal (fin de rama).

12. [CONCLUSIÓN] Lumbalgia mecánica sin signos estructurales mayores

id: bk_nonspecific

Resumen: Sin radicular claro ni RF. Reevaluar si aparecen alarmas.

Hipótesis:

- **Lumbalgia mecánica inespecífica** (alta) — Sin cluster ciático ni inflamatorio.

→ Nodo terminal (fin de rama).